جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نجلاء عبدالعظيم عبدالوهاب عطيه
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** اوسيم **العنوان :** -----
رقم البطاقة : 28601012117204 **رقم التليفون :** 01147446788 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 01-01-1986 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي زولاديكس تحت الجلد لمده 6 شهور [14163] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نجلاء عبدالعظيم عبدالوهاب عطيه
National ID: 28601012117204

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Goserelin (Zoladex) subcutaneous**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	: الأستاذه / نجلاء عبدالعظيم عبدالعظيم عبدالوهاب	Request No.	: 13008899
Patient No.	: 28601012117204	Request Date	: 16/08/2023
Path No.	: 2688/23	Verification Date	: 28/08/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 37 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data:
Bilateral breast lesions

Nature of specimen:
Tru cut biopsies, collected at 15/8/2023 , 3:40 pm

Gross examination:
1)Right breast:
Four greyish white tissue cores up to 1.5 cm , totally submitted.
2)Left breast:
Four greyish white tissue cores up to 1 cm , totally submitted.
Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:
1)Right breast:
* Histological type: Invasive duct carcinoma .
* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II
* DCIS: Could not be detected within the limits of biopsy recieved.
*Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy recieved.
*IPT:
ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8)
PR: Weak nuclear reaction in 15% of tumor cells (Allred score 4/8)
Her-2: Weak membrane reaction in 10% of tumor cells (score 1+)
Ki 67: 10 % nuclear reaction in tumor cells
2)Left breast:
-Examination of the stained slide reveals increase in glandular elements plus stromal

Verified by :
dr.esraa magdy

Room No. (4) - First Floor-Building No. 937- Nile Corniche - Nile El Qubesi- Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / نجلاء عبدالعظيم عبدالعظيم عبدالوهاب	Request No.	: 13008899
Patient No.	: 28601012117204	Request Date	: 16/08/2023
Path No.	: 2688/23	Verification Date	: 28/08/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 37 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

fibrosis and sclerosis that distorts and compresses glands. Centrally is more cellular with distorted and compressed ductules; peripherally has more open or dilated ductules. Myoepithelial cells are indistinct in the examined section.
IPT:
P63 and Calponin:Diffuse positive both inside the ducts and in linning myoepithelial cells.

Diagnosis:
1)Rightt breast lesion, tru cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II .
IPT:
ER: Positive (score 8/8).
PR: Positive (score 4/8).
HER-2: (Score 1+).
KI67: Positive in 10% of tumor cells.
2)Left breast lesion, tru cut biopsy:
-Benign complex sclerosing lesion.

Prof.Gamal Abdelatty
Dr.Menan Hossam
Dr.Menna Nabil

Verified by :
dr.esraa magdy

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (257) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 257- Nile Corniche - Misr El Qadema- Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــحة والسكـان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Naglaa Abd Al Azeem Abd Al Wahab Atteya	Date : 23/11/2024
Exam : C.T ABDOMEN &PELVIS	Age : 39 Year(s)
Medical ID: 3372/2023	Pat. ID: 41693

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

COMPARED with last study dated 24/1/2024

- ***Findings: reported case of RIGHT BCS***

  - Right breast operative bed shows focal area of parenchymal distortion, with increased skin thickness. With no evidence of recurrence.
  - **Still noted**
    - Bilateral prominent axillary level I and II lymph nodes and the largest seen in right measuring 12x6 mm.
    - Middle lung lobe and left LLL atelectatic bands.
  - No sizable pulmonary nodules or masses
  - No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
  - No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
  - No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
  - Thymic hyperplasia is seen
  - Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
  - Lytic manubrium sternum lesion for bone scan correlation.

1. ***Abdomen and pelvis:***

- The liver is enlarged in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions (on non-contrast) or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Naglaa Abd Al Azeem Abd Al Wahab Atteya	Date : 23/11/2024
Exam : C.T ABDOMEN &PELVIS	Age : 39 Year(s)
Medical ID: 3372/2023	Pat. ID: 41693

- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Still noted small lucent area at manubrium

OPINION:

- **Status follow up running a rather stationary course since the last study**

:

Prof. Menna Tallah Hanafy, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]